

Sześć klasterów *C-PTSD* wg ICD-11

Trzy klaster PTSD + trzy DSO (zaburzenia organizacji self). To nie ilościowy wariant PTSD — strukturalnie odrębne zaburzenie.

CZAS: 15 min psychoedukacji **REALIZACJA:** pierwsza faza terapii

ŹRÓDŁO: Herman (1992, *Trauma and Recovery*); ICD-11 (2018, WHO); Cloitre i in. (2019, metaanaliza); Karatzias i in. (2019); Teicher & Samson (2016)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **trzy klaster PTSD**: intruzje, unikanie, poczucie zagrożenia (ang. *sense of threat*). W sekcji 02 — **trzy klaster DSO** (ang. *Disturbances in Self-Organization*): dysregulacja afektu, negatywna koncepcja siebie, trudności relacyjne. Sekcja 03 — **różnicowanie** z BPD i z „klasycznym” PTSD; istotne dla planu leczenia. Sekcja 04 — twoja samoocena sześciu klasterów (0-10) jako mapa do rozmowy z terapeutą.

DLACZEGO TO DZIAŁA

C-PTSD (*Complex Post-Traumatic Stress Disorder*) jest oficjalną diagnozą w klasyfikacji **ICD-11** (WHO, 2018; obowiązuje od 2022), *nie* w DSM-5. Powstaje po **przewlekłej, powtarzającej się traumie interpersonalnej** — najczęściej w okresie zależności i niemożności ucieczki: dzieciństwo (przemoc fizyczna, seksualna, emocjonalna, zaniedbanie, bycie świadkiem przemocy), długotrwała przemoc domowa, handel ludźmi, tortury, sytuacje niewoli. Pojęcie wprowadziła Judith Herman (1992, *Trauma and Recovery*) — walka o uznanie diagnostyczne trwała 26 lat; DSM odrzucił dwukrotnie, ICD-11 uznało. ICD-11 definiuje C-PTSD przez **sześć klasterów**: trzy klaster klasycznego PTSD (re-eksperyencowanie / intruzje, unikanie, poczucie zagrożenia) **plus** trzy klaster DSO (zaburzenia organizacji self): (1) **dysregulacja afektu** — niestabilność, wybuchy, odrętwienie, trudności z modulacją emocji; (2) **negatywna koncepcja siebie** — głębokie poczucie bycia złamanym, bezwartościowym, brudnym, zinternalizowany wstyd (nie tylko niska samoocena); (3) **zaburzenia relacyjne** — brak zaufania, izolacja, rewiktymizacja, trudności z bliskością. Cloitre i in. (2019, metaanaliza): **C-PTSD jest odrębne od PTSD** — różna struktura czynnikowa, różne predyktory (powtarzająca się trauma kontra pojedyncze zdarzenie), różne leczenie (fazowe kontra bezpośrednia ekspozycja). Karatzias i in. (2019): rozpowszechnienie 1-8% populacji ogólnej, do 50% w populacjach wysokiego ryzyka. Neurobiologia: chroniczna trauma dziecięca **zmienia strukturę rozwijającego się mózgu** — mniejszy hipokamp, mniejsza kora przedczołowa, nadreaktywne ciało migdałowate (Teicher & Samson, 2016, metaanaliza 25 badań neuroobrazowych). Konsekwencja kliniczna: **klinicysta uczony tylko DSM-5 nie zdiagnozuje C-PTSD** — pacjent dostaje 8-12 sesji terapii ekspozycyjnej, terapia destabilizuje, nie adresuje DSO.

01 Klaster 1-3 — wspólne z PTSD

1 · INTRUZJE

Powracające wspomnienia: koszmary, retrospekcje (ang. *flashbacks*), wrażenie, że trauma „dzieje się teraz”. Wyzwalacze somatyczne, dźwiękowe, węchowe. Często pojawiają się znienacka, bez świadomej przyczyny.

2 · UNIKANIE

Ucieczka od wszystkiego, co przypomina traumę: miejsc, ludzi, rozmów, wspomnień, emocji. Często niepełne i kosztowne — wymaga ciągłej czujności i zawęża życie.

3 · POCZUCIE ZAGROŻENIA

Stała czujność (ang. *hyperarousal*): wzmożona reakcja na bodźce, problemy ze snem, drażliwość, trudności z koncentracją. Ciało „nie ufa”, że jest bezpiecznie.

02 ? Klaster 4–6 — DSO, specyficzne dla C-PTSD

4 · DYSREGULACJA AFEKTU

Trudności z modulacją emocji: niestabilność, intensywne wybuchy lub odrętwienie. Reakcje „za duże” lub „za małe”. Trudność z powrotem do równowagi. *Biologiczna*, nie „słabość”.

5 · NEGATYWNE SELF

Zinternalizowany wstyd: poczucie bycia złamanym, bezwartościowym, brudnym. Nie tylko niska samoocena — głębokie przekonanie „jestem zły/-a”, obecne *stałe*, nie chwiejne jak w BPD.

6 · ZABURZENIA RELACYJNE

Trudności z bliskością: brak zaufania, izolacja, rewiktyzacja (powtarzanie się szkodliwych relacji), niemożność „opuszczenia gardy”. Bliskość = zagrożenie.

03 ? Różnicowanie — z czym łatwo pomylić

PTSD KONTRA C-PTSD

PTSD: pojedyncze lub ograniczone czasowo zdarzenie (wypadek, napaść). Strach *kontekstowy*, związany ze specyficznym bodźcem.

C-PTSD: trauma powtarzająca się, przewlekła, w okresie zależności. Strach *uogólniony*, przeniesiony na całe relacje, ciało, świat. Plus 3 DSO.

C-PTSD KONTRA BPD

BPD: obraz siebie *chwiejny*, oscylujący (czarne-białe). Lęk przed porzuceniem, intensywne idealizacja-dewaluacja.

C-PTSD: obraz siebie *stabilnie negatywny*, nie chwiejny — głębokie poczucie bycia złamanym, obecne *stałe*. Wycofanie zamiast walki o bliskość.

Implikacja kliniczna: C-PTSD wymaga *fazowego* leczenia (Herman, 1992; ISTSS, 2019) — najpierw stabilizacja (faza 1, miesiące do lat), potem przetwarzanie traumy (faza 2), na końcu integracja (faza 3). **Bezpośrednia ekspozycja bez stabilizacji może retraumatyzować** — pacjent traci okno tolerancji, dysocjuje, dekompensuje. Cloitre i in. (2012, RCT): fazowy STAIR + NST przewyższał samą ekspozycję u osób po powtarzającej się traumie dziecięcej.

04 ✎ Samoocena sześciu klasterów (0–10)

To *nie* jest pomiar diagnostyczny (do tego służy ITQ pod nadzorem klinicysty). To wstępna mapa do rozmowy z terapeutą.

KLASTER	WYNIK 0–10	CO KONKRETNIE? — PRZYKŁAD Z OSTATNIEGO MIESIĄCA
1 · Intruzje PTSD		
2 · Unikanie PTSD		
3 · Poczucie zagrożenia PTSD		
4 · Dysregulacja afektu DSO		
5 · Negatywne self DSO		
6 · Trudności relacyjne DSO		

Klucz: C-PTSD to *nie* słabość ani „przewrażliwienie” — to **biologiczna konsekwencja** przewlekłej traumy w okresie zależności i niemożności ucieczki. Trauma dziecięca zmienia strukturę rozwijającego się mózgu (Teicher & Samson, 2016). To wyjaśnia, dlaczego dysregulacja emocji, wstyd i trudności relacyjne *nie ustępują* samej woli czy „pozytywnym myśleniem”. Plan leczenia: fazowy, nie krótkoterminowy. Faza 1 (stabilizacja) trwa zwykle 6–12 miesięcy lub dłużej — i to *nie* opóźnienie, to fundament. Bez niej kolejne fazy nie zadziałają.

△ Diagnoza C-PTSD wymaga klinicznej oceny przez psychologa lub psychiatrę znającego ICD-11 i ITQ (International Trauma Questionnaire, Cloitre i in., 2018). Ten handout jest psychoedukacją, nie autodiagnozą. W kryzysie suicydalnym lub samookaleczeniu — Telefon zaufania 116 123 (dorośli), 116 111 (młodzież, codziennie 24/7).